

INFECCIONES ORALES Y MAXILOFACIALES

Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez, Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena

INTRODUCCIÓN

La causa mas frecuente de infección maxilofacial es el origen odontogénico, siendo la causa principal la caries. Puede afectar a cualquier pieza dental siendo los terceros molar inferiores la pieza mas frecuentemente afectada. Hay otras causas menos frecuentes como osteonecrosis mandibular, infección de glándula salivar mayor (parótida, submaxilar, sublingual).

La inflamación odontogénica progresa en fases, comienza con la entrada de gérmenes por el canal pulpar, se propaga a región apical produciendo periodontitis y absceso periapical, progresa, y romperá el periostio y se desarrollará la fase de flemón y la posterior celulitis. Si avanza se producirá la formación de absceso, y se diseminará por los espacios anatómicos locales.

Los espacios seguros para vía aérea son:

- Vestibular, Palatino, Temporal, Bucal.

Los espacios mas comprometedores para la vía aérea son:

- Submentoniano, submandibular, perifaríngeo.
- Sublingual: espacio peligroso por la elevación del suelo de boca, que desplaza la lengua hacia el paladar y puede ocasionar trastorno moderado en forma de disnea, disfagia y dislalia.
- Pterigomandibular: muy habitual la producción de trismus. Su peligrosidad viene por la posibilidad de propagación hacia el espacio faríngeo.



DIAGNÓSTICO

Síntomas y signos locales de inflamación. En el absceso periapical se podrá apreciar abombamiento de cortical ósea e inflamación y dolor local. Si progresa, se puede observar tumefacción fluctuante que se puede asociar a exudación purulenta. Puede asociar trismus por irritación de musculatura maseterina.

- Hay signos que pueden ponernos en sobre aviso de una infección potencialmente grave que pudiera comprometer vía aérea como son disnea, disfagia, voz gangosa, elevación suelo de boca, alteraciones movilidad lingual.

En infecciones más avanzadas puede haber datos de sepsis y formas especiales de infecciones como la angina de Ludwig.

La progresión más temida de un absceso maxilofacial es la mediastinitis que se presenta como

tumefacción cervical lateral por debajo de musculo esternocleidomastoideo, doloroso y podría asociar tortícolis. Presenta disnea severa, dolor torácico retroesternal, tos no productiva, fiebre alta y afectación del estado general.

No se necesitan hacer pruebas de imagen para el diagnóstico de un absceso simple.

En infecciones complicadas se debe extraer analítica completa, medir la saturación de oxígeno, y realizar un TC de cuello con contraste para delimitar espacios afectos y establecer un plan quirúrgico de drenaje.

TRATAMIENTO

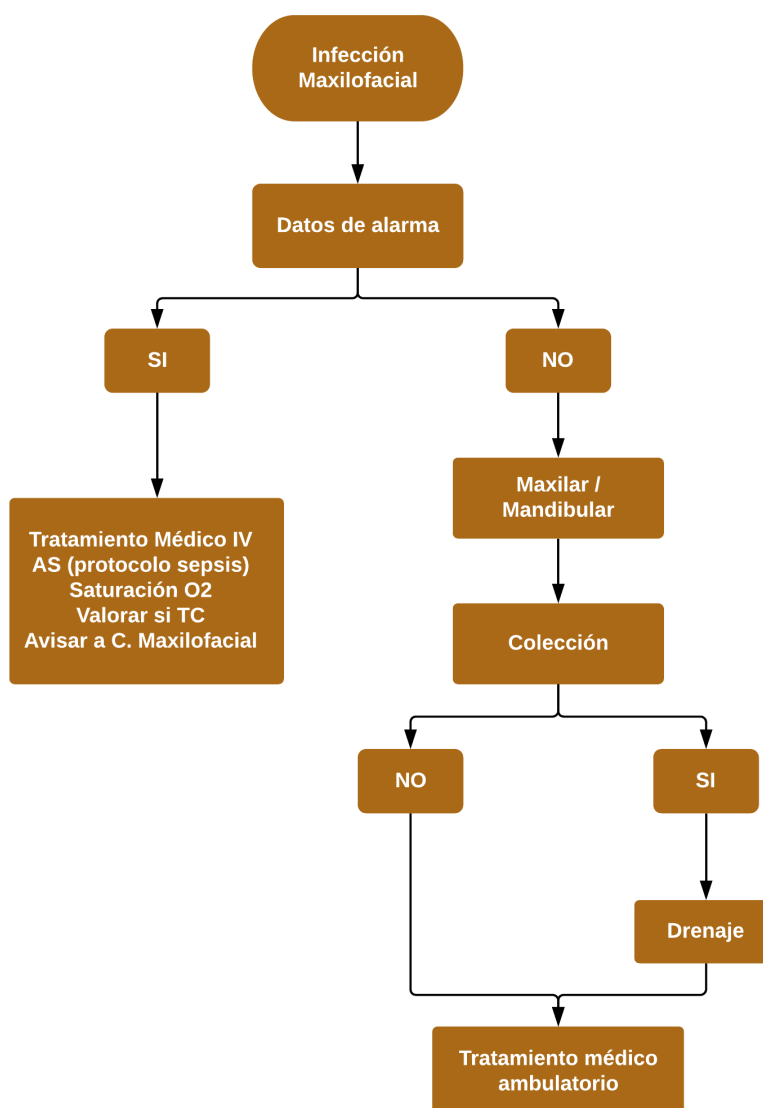
Toda colección debe tratarse con drenaje. En función de espacio afecto se podrá hacer con anestesia local en la sala de urgencias, mediante incisión directa en la zona mas fluctuante del absceso, drenando el material purulento, realizando lavados con suero y solución iodada y dejando un drenaje en la cavidad.

Los mas graves o menos accesibles se deberán hacer en quirófano con anestesia general y abordajes mas complejos.

En un absceso no complicado el tratamiento será, drenaje de la colección, y de manera ambulatoria, antibiótico (Augmentine 875mg cada 8h durante 7 días), analgesia y revisión por su dentista.

Un absceso complicado que presente signos de alarma sea en el espacio que sea, se debe instaurar tratamiento intravenoso que debe consistir en:

- **Antibiótico:** Augmentine 1g IV cada 8h, en caso de alergia Ciprofloxacino 400mg cada 12 horas asociado a Clindamicina 600mg cada 8 horas.
- **Analgesia:** Según necesidad del paciente.
- **Corticoides:**
 - Bolo de Actocortina 100mg IV.
 - Urbason 40mg IV cada 8h.
- **Relajante muscular** para disminuir trismus: Diazepam 5mg IV cada 8h.



BIBLIOGRAFÍA

- Martín Granizo R, López Davis A. Cirugía Oral y Maxilofacial. Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 3ª ed. Barcelona: Médica Panamericana; 2011.
- García Marín F, Ochandiano Caicoya S. Cirugía oral. Carlos Navarro Vila. 2ª ed. Madrid: Aran; 2009.
- Sánchez R, Mirada E, Arias J, Paño JR, Burgueño M. Severe odontogenic infections: Epidemiological, microbiological and therapeutic factors. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16(5):e670-6.